

Identyfikacja *obron* w sesji

Podstawowa umiejętność STPP. Obrony zdradzają się w języku, ciele, przepływie tematów i wzorcu relacji. Nazywasz obserwację, nie etykietę — i pytasz, zamiast oskarżać.

CZAS: 30 min Każda sesja — stała obserwacja; analiza nagrań

ŹRÓDŁO: Davanloo (1980); McCullough (1997)

JAK UŻYWAĆ

Rozpoznajesz obrony w czasie rzeczywistym i nazywasz **obserwację, nie obronę**. Zamiast „to intelektualizacja” mówisz: „zauważyłem, że gdy weszliśmy w temat matki, odsunęła się Pani od uczuć — zaczęła Pani opisywać jak obserwator”. Potem pytasz, nie oskarżasz: „ciekawi mnie — czemu w tym momencie żart?”. Po sesji notujesz rozpoznane obrony do formułacji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Jeśli nie zauważasz obron, przyjmujesz je jako fakty (pacjent „po prostu nie pamięta”, „nie wie, co czuje”) i praca zostaje powierzchowna. Obrony manifestują się przez język („logicznie”, „z perspektywy” — intelektualizacja), ciało (napiecie, dystans), przepływ (nagła zmiana tematu — wyparcie), wzorzec relacji (spóźnienie, zapomniane zadanie — odgrywanie, ang. *acting out*) i niewspółmierny afekt (opowieść o śmierci tonem reportażu — izolacja afektu). Twoje własne znużenie czy nuda też bywają śladem obrony pacjenta.

01



Gdzie szukać sygnałów

Język — „logicznie”, „z perspektywy”, „generalnie”

Twoje ciało — znużenie, nuda, zniecierpliwienie

Wzorzec relacji — spóźnienie, zmiana terminu, zapomniane zadanie

Ciało pacjenta — napięcie, skrzyżowane ręce, uśmiech nie do treści

Przepływ — nagła zmiana tematu, „chciałam o czymś innym”

Afekt — trauma opowiadana bez emocji

02



Trzy typy obron — przykłady

BEHAVIORALNE

— milczenie, żart

POZNAWCZE

— intelektualizacja

EMOCJONALNE

— niewspółmierny afekt

03 Nazwij obserwację, nie obronę

Sformułuj zdanie opisujące to, co widzisz, bez etykiety teoretycznej. „Zauważyłem, że gdy dotknęliśmy ojca, zaczęła Pani mówić o pracy.” Zapisz wersję dla obrony, którą widzisz najczęściej u tego pacjenta.

MOJA OBSERWACJA DO NAZWANIA

04 Zapisz materiał po sesji

Po sesji zanotuj rozpoznane obrony — to porządkuje formulację i planowanie. Zwróć uwagę zwłaszcza na intelektualizację, najczęstszą obronę w STPP.

ROZPOZNANE OBRONY TEJ SESJI

Klucz: najczęstszą obroną w STPP jest intelektualizacja — pacjent mówi racjonalnie i przekonująco o swoich problemach. Nie daj się uwieść; nazwij, że to „rozmawianie o”, a nie „doświadczenie”. Terapia bez doświadczenia afektu staje się długotrwałą intelektualizacją obronną.